

Nocne ataki *paniki*

Wybudzenie z fazy NREM bez treści snu. Nie są koszmarami — to ten sam mechanizm co daytime, tylko w ciemności.

CZAS: praca ciągła Dziennik + standardowa CBT

ŹRÓDŁO: Uhde (1994); Craske & Tsao (2005); Craske & Barlow (2008)

JAK UŻYWAĆ

Postępuj według **6-krokowego protokołu** przy każdym wybudzeniu (strona 2). Następnego dnia zapisz w dzienniku godzinę wybudzenia, czas trwania ataku, myśl katastroficzną. Stosuj standardową terapię poznawczo-behawioralną dla paniki — mechanizm jest ten sam. Jeśli rozwinął się *lęk przed zasypianiem*, dodaj higienę snu i terapię poznawczo-behawioralną bezsenności.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Nocne ataki to wybudzenia ze snu w pełnej panice, **bez wyzwalacza sytuacyjnego i bez treści snu**. Występują u 44–71% osób z zaburzeniem panicznym (Craske i Tsao, 2005). Polisomnografia (Uhde 1994): ataki powstają w fazie NREM, głównie w przejściu między fazą 2 a 3 — nie w REM. **Nie są koszmarami**. Mechanizm: subtelne pobudzenie fizjologiczne interpretowane katastroficznie w momencie wybudzenia. Craske i Barlow (2008): standardowa terapia poznawczo-behawioralna redukuje nocne ataki w tym samym tempie co daytime — bez dodatkowego komponentu.

01 ✓ Cztery fakty, które rozbijają mity

1 · TO NIE KOSZMAR

Koszmary powstają w fazie REM i mają *treść* — sceny, obrazy, fabuła. Nocne ataki powstają w NREM, bez treści. Budzisz się w pełnym lęku, ale **nie pamiętasz nic strasznego**, bo nic ci się nie śniło.

2 · TWÓJ SEN NIE JEST USZKODZONY

Architektura snu pozostaje prawidłowa. To *system detekcji zagrożenia* jest nadwrażliwy — odpala się na subtelnych zmianach fizjologicznych w trakcie snu, których zdrowi nie zauważają.

3 · TO NIE BEZDECH, NIE ZAWAŁ

Pacjenci często boją się o *bezdech senny* lub kardiologię. Badania (polisomnografia, EKG, holter) są zwykle prawidłowe. Jeśli masz wątpliwości — wykonaj badanie raz, ale nie powtarzaj „na wszelki wypadek”.

4 · MECHANIZM = DZIENNE ATAKI

Subiektywnie nocne są bardziej przerażające (ciemność, dezorientacja, brak kontekstu), ale mechanizm jest **identyczny**: katastroficzna interpretacja odczuć cielesnych. Te same techniki działają.

02 ✗ Najgroźniejsza pułapka — wtórna bezsenność z lęku przed snem

Craske (2005): pacjenci, którzy zaczynają *unikać snu, monitorować bicie serca w łóżku lub brać leki nasenne „profilaktycznie”*, rozwijają uporczywy wzór trudniejszy do leczenia niż pierwotne nocne ataki. Świadomie obserwuj te zachowania.

Opóźnianie pójścia spać — „jeszcze pooglądam, żeby się zmęczyć”.

Spanie w innym pokoju „bo tam się czuję bezpieczniej”.

Sprawdzanie pulsu / oddechu przed zaśnięciem, w nocy.

Leki nasenne profilaktycznie co wieczór, „żeby na pewno spać”.

03 Protokół 6 kroków — co robić przy wybudzeniu

1 · Orientacja i nazwanie

W momencie wybudzenia, na głos lub w myśli: „*To jest atak paniki. Jest noc. Jestem w łóżku. Jestem bezpieczny/-a.*” Proste zdania zakotwiczą w rzeczywistości.

2 · Spowolnij oddech

Wdech 4 s nosem, wydech 6 s ustami. **Nie hiperwentyluj.** Cel: 6–8 oddechów/min przez 2 minuty.

3 · Nie wstawaj w pierwszych 5 min

Wstawanie, zapalanie świateł, telefon — *nasilają* pobudzenie. Zostań w łóżku, oddychaj, przyjmij, że minie.

4 · Po 20 min — kontrola bodźców

Jeśli nie zasypiasz: wstań, idź do innego pokoju, nudna czynność bez ekranu (czytanie nudnej książki). Wróć do łóżka *dopiero przy senności*.

5 · Zapis w dzienniku rano

Godzina wybudzenia, czas trwania, myśl katastroficzna, co zrobiłem/-am, jak minął dzień. Dane pomogą dostrzec wzorce.

6 · Czego unikać

„*Dlaczego się obudziłem/-am?*” — rumiacja. „*Co jest nie tak?*” — katastrofizacja. Nie szukaj „przyczyny” w nocy.

04 Higiena snu — fundament profilaktyki

Stałe godziny snu — kładź się i wstawaj o tej samej porze, także w weekendy.

Brak alkoholu przed snem — paradoksalnie pogłębia nocne ataki przez efekt z odbicia.

Łóżko = sen (i seks) — nie pracuj, nie oglądaj, nie jedz w łóżku.

Brak kofeiny po 14:00 — kawa, herbata, energetyki, czekolada.

Brak ekranów 30 min przed snem — światło niebieskie hamuje melatoninę.

Chłodne pomieszczenie — 18–20°C. Ciepło nasila pobudzenie i ataki.

05 Dziennik nocy — 7 nocy

DZIEŃ	GODZ. WYBUDZ.	CZAS ATAKU	SUDS MAX	KATASTROFICZNA MYŚL	CO ZROBIŁEM/-AM
<i>Pn</i>					
<i>Wt</i>					
<i>Śr</i>					
<i>Cz</i>					
<i>Pt</i>					
<i>Sb</i>					
<i>Nd</i>					

Klucz: najsilniejszy komunikat psychoedukacyjny: „*Twój sen nie jest uszkodzony, Twoje ciało nie atakuje Cię w nocy. To ten sam mechanizm katastroficznej interpretacji odczuć, który działa w dzień — tylko bez kontekstu wyzwalacza, co czyni go przerażającym.*” Ramka „**to mój znany problem, nie nowy**” rozbija poczucie utraty kontroli nad snem.